

# Agosto: 2 suspensiones en 152 cirugías programadas

1,32 %

tasa hábil de suspensión · agosto 2026

cirugía mayor electiva programada de lunes a viernes ·  
misma fórmula y fuente de todos los meses

12,11 %

agosto 2025 a la misma fecha · 23 de 190

+13,5 %

cirugía mayor hábil · enero–agosto vs 2025

12 de 21 días

sin Pabellón 2 en agosto · explica la menor producción del mes

Versión breve para el comité · la versión completa (49 láminas, métodos y tablas) queda como anexo.

## La suspensión de agosto cayó a la décima parte de la de 2025

12,11 %



1,32 %

agosto 2025

23 suspensiones de 190 programadas

agosto 2026

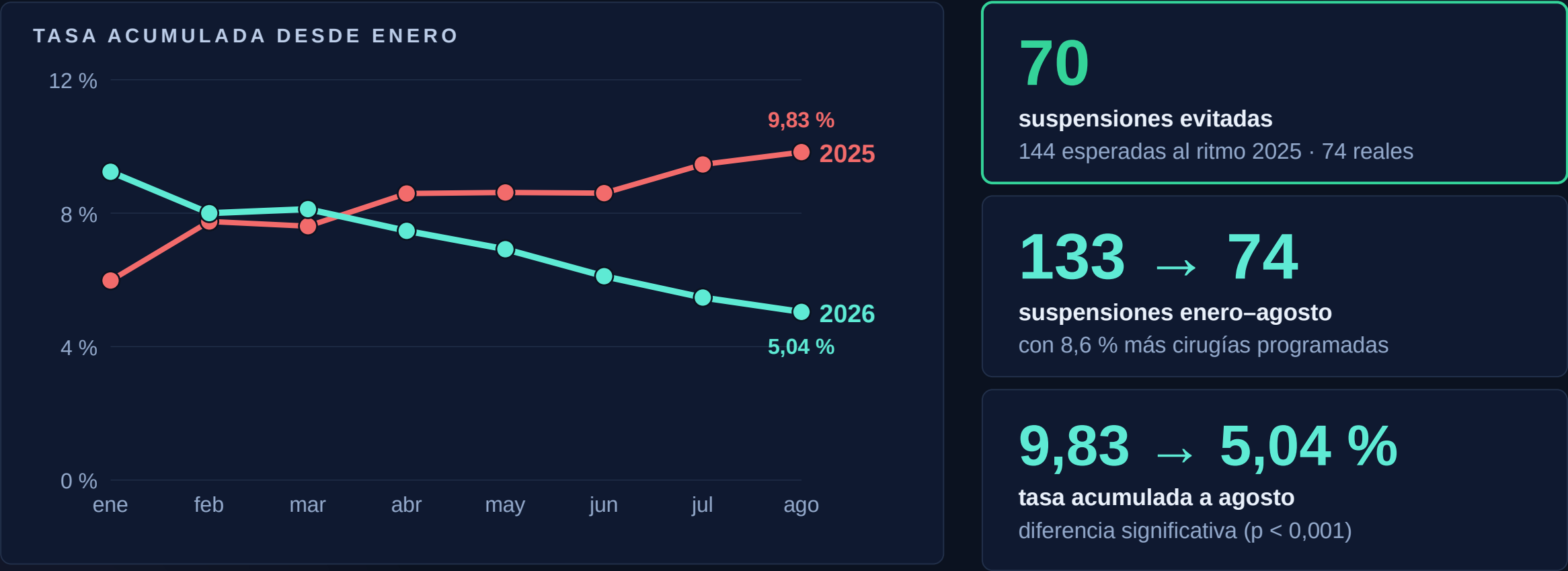
2 suspensiones de 152 programadas

**12 pacientes operados que, al ritmo de 2025, se habrían suspendido**

Con la tasa de 2025 se esperaban 14 suspensiones sobre 152 programadas; hubo 2. Diferencia estadísticamente significativa ( $p < 0,001$ ).

Cirugía mayor electiva programada de lunes a viernes (monitoreo diario). Misma fórmula en ambos años.

# En el año llevamos 70 suspensiones menos que al ritmo de 2025



Acumulado = suspendidas / programadas desde enero (suma sobre suma). "Evitadas" es un cálculo aritmético; no atribuye causa.

# Tres meses seguidos bajo el límite de control: la mejora es real



Un mes con 1–2 casos varía por azar; la evidencia está en la secuencia de tres meses y en el acumulado.

## Producimos más cirugía mayor en horario hábil que en 2025

**+13,5 %**

**cirugía mayor electiva de lunes a viernes**

1.657 → 1.880 operaciones entre enero y agosto · los mismos 173 días hábiles

**+2,4 %**

todas las fechas · 3.307 → 3.386

**-8,7 %**

fin de semana · jornadas de oftalmología

**+14,1 %**

cirugía mayor de urgencia

Agosto: 411 cirugías mayores electivas (201 en horario hábil) frente a 419 en agosto 2025, con un pabellón menos parte del mes.

# Julio y agosto se operaron con un pabellón menos

## 9 de 21

**días con Pabellón 2 en agosto**

tres lunes sin enfermera y obras en la cubierta desde el 12 de agosto

**≈ 48 cirugías**

electivas no realizadas por los 12 días perdidos

**3,9 por pabellón-día**

el rendimiento por pabellón se mantuvo

**11,8 por día**

cirugías mayores L-V con P2 completo · agosto 2025: 11,0

Estimación con la productividad observada por pabellón-día. Julio: falta confirmar los días sin pabellón para aplicar la misma regla.

## Hubo 38 suspensiones en total; solo 2 cuentan para el indicador

38

suspensiones registradas  
todas las modalidades y días

19 + 19

lunes a viernes + fin de semana  
18 son oftalmológicas de dos jornadas

18

sin causa registrada  
casi la mitad del registro

**Las 18 oftalmológicas no son 18 fallas: son dos jornadas (8–9 y 22–23 de agosto)**

Concentración imposible por azar ( $p < 0,001$ ). Falta registrar la causa por jornada: capacidad, dotación, insumos o inasistencia.

El indicador oficial cuenta solo la cirugía mayor electiva de lunes a viernes; el resto consume preparación, agenda y pabellón igual, pero no se ve.

# La causa número uno es el error de programación

**10****evitables**

programación, ayuno, exámenes, instrumental

**5 + 5****potencialmente evitables + no evitables****18****sin causa registrada**

no se clasifican

Rojo: evitable · ámbar: potencialmente evitable · azul: no evitable. Julio tuvo 5 errores de programación; agosto 7.



# El lunes sigue siendo el día frágil de la semana

**6 de 19**

registros de lunes a viernes fueron en lunes

**2 de 2**

eventos del indicador cayeron en lunes

**3 lunes**

sin tabla en Pabellón 2 por falta de enfermera

**Histórico: el lunes suspende 11,09 %, más que cualquier otro día (significativo)**

Medida: confirmar pacientes y exámenes el viernes en la tarde, y asegurar la dotación de enfermería del lunes en Pabellón 2.

Agosto solo no alcanza para demostrarlo ( $p = 0,16$ ); el histórico de 16 meses sí ( $Z = 2,09$ ).

# El día quirúrgico de agosto, en un solo caso

UN CASO ELECTIVO TÍPICO DE LUNES A VIERNES · MINUTOS (MEDIANAS)



De la entrada a la salida del quirófano: 100 minutos de mediana. Luego 18 minutos de recambio y entra el siguiente.



Medianas del export SITGEQ 830 (agosto, lunes a viernes, electivos). Las 08:00 y 09:00 son referencias, no metas.

## Los recambios largos se acortaron; el caso típico no cambió

**18 min**

recambio · mediana

julio 19 · sin cambio

**22,6 min**

recambio · media

julio 29,5 · -7 min

**43 min**

recambio · uno de cada diez supera

julio 59 · -16 min

### Mejor

El primer paciente entra a las 07:55 (julio 08:02) y la primera incisión es a las 08:45 (julio 08:50).

### Pendiente

Solo 63 % de las primeras incisiones ocurre antes de las 09:00 (agosto 2025: 85 %). El mediodía suma 33 horas sin actividad.

Recambio neto: de la salida de un paciente al ingreso del siguiente, descontando el almuerzo (12:30–14:00).

# Los indicadores del escritorio SITGEQ, en una sola vista



Sin la tasa de suspensión del escritorio (7,5 %): usa otro numerador y otra cohorte que el indicador del comité (1,32 %). Captura del escritorio, septiembre 2026.

# Horario continuo: entre 11 y 17 cirugías más al mes

LO QUE MIDE AGOSTO EN LA FRANJA 12:30-14:00

**33 h 35**

de pausas entre pacientes en la franja  
40 de 141 recambios · 39 pabellón-días

**16 jornadas**

con bloque libre continuo  $\geq 60$  min  
en 12 fechas · de  $\geq 90$  min: solo 2

**2 h por caso**

100 min de quirófano + 18 de recambio  
caso corto:  $\approx 1$  h 20

CUÁNTOS PACIENTES MÁS, SI HAY GENTE PARA ESE HORARIO · POR MES

**16**

**conservador**

un caso corto en cada bloque libre  
observado de  $\geq 60$  min

**11 a 17**

**medido**

21,6 h libres (pausas menos recambio  
normal): 11 casos típicos o 17 cortos · +5 a  
+8 % de la CME hábil

**hasta 38**

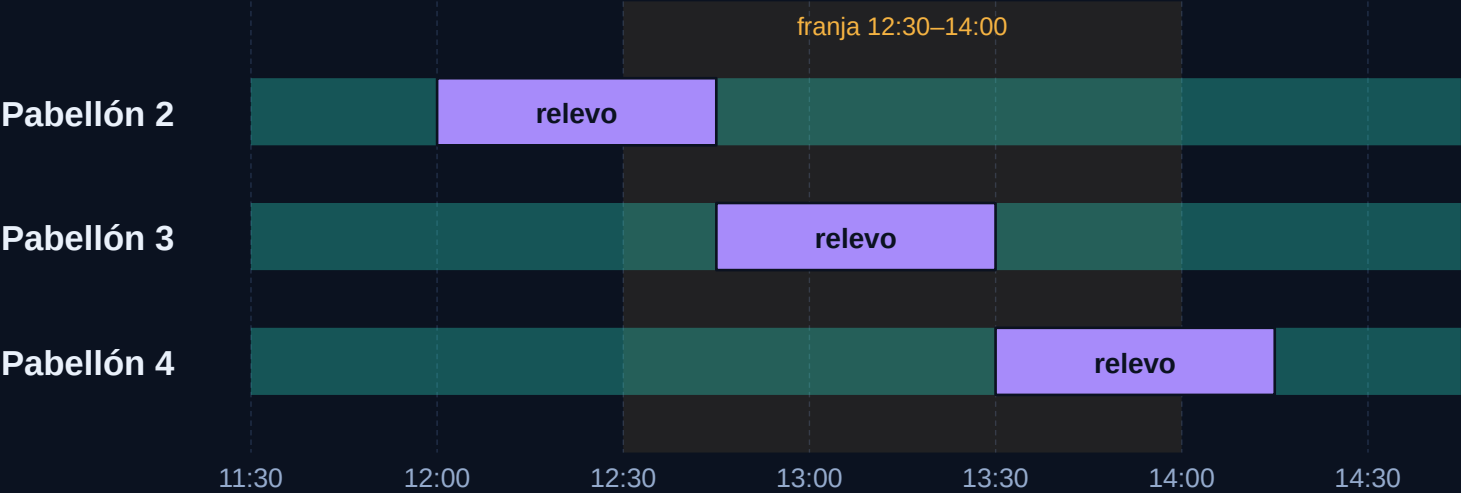
**tope teórico**

la franja completa en los 3 pabellones  $\times$  21  
días (76,5 h); 48 con Pabellón 2 completo

Al año: 130 a 200 cirugías más en Quilpué; 300 a 470 en el HPMM con 7 pabellones. Requiere paciente preparado, equipo, instrumental y recuperación: no se suman fragmentos de salas o días distintos.

# Relevo en escalera y un piloto de cuatro semanas

RELEVO ESCALONADO · UN EQUIPO CUBRE 45 MIN EN CADA PABELLÓN



verde: el pabellón sigue operando · violeta: 45 min en que el equipo titular almuerza y el equipo de relevo cubre

**1 equipo**

**de relevo, por función**

enfermera, TENS, arsenalera y anestesiólogo  
· 2 h 15 por día · 47 h al mes

**0 min**

**de pabellón detenido al mediodía**

el descanso se mantiene: cambia el turno, no la pausa

## Piloto de 4 semanas: jornadas con y sin relevo, misma agenda documentada

Registrar por intervalo: sala lista, paciente listo, equipo disponible, causa del bloqueo y hora de reanudación. Comparar hora final de tabla, casos completados, carga de trabajo y recambio bruto y neto. Decisión en comité.

Propuesta a validar con las jefaturas asistenciales y gestión de personas; el informe del 6-sep recomienda comparación concurrente (aleatorizar si es factible).

## Qué esperar si el régimen se sostiene, y qué pasa si no

**2 a 10**

**suspensiones en septiembre**

pronóstico prudente · más de 10 es señal de deterioro

**9 · 29 · 69**

**septiembre a diciembre**

si se sostiene · si sube a 4 % · si vuelve 2025

**66 vs 505**

**al año en el HPMM (7 pabellones)**

régimen actual vs tasa 2025 · 439 pacientes de diferencia

**El traslado al Marga Marga multiplica por 2,3 la exposición: amplifica la tasa que llevemos**

Sostener el régimen depende de lo que se institucionalice antes del traslado: causal completa, lunes blindado, dotación y camas de rescate.

Escenarios binomiales con el volumen de cada período; no incorporan estacionalidad ni cambio de mezcla.

# Cinco decisiones para septiembre

1

## Completar la causa de las 38 suspensiones

por jornada en el fin de semana; "sin causa determinada" disponible

2

## Blindar el lunes y recuperar el pabellón-día

confirmación el viernes en la tarde · enfermería asegurada en Pabellón 2

3

## Auditar el error de programación

7 casos, 3 cirugías mayores directas · separar error de agenda de indicación o insumo

4

## Consentimiento y ayuno antes de la tabla

medida del 31 de agosto: sin consentimiento firmado no hay tabla

5

## Piloto de horario continuo y registro operable

equipo de relevo en escalera, 4 semanas con y sin cobertura · campos de julio en CancelOS



# De dónde salen las cifras

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Monitoreo diario (ene-2025 → ago-2026)             | tasa de suspensión, producción, comparación con 2025 y control estadístico |
| Informe de suspensiones de agosto (2-sep)          | las 38 suspensiones: causas, día, modalidad y evitabilidad                 |
| Exports SITGEQ 787 y 830                           | tiempos: primer caso, recambio, ocupación, pabellón y especialidad         |
| Informe "Evolución del proceso quirúrgico" (6-sep) | series de recambio y primeros casos 2024–2026; evaluación de algoritmos    |
| Comité de julio y SPC histórico                    | regla de evitabilidad, línea base 2025, efecto lunes y proyección HPMM     |

Anexo: la versión completa (49 láminas) tiene los métodos, las tablas, las pruebas estadísticas y las notas de cada cifra.

Información agregada, sin datos personales. Los identificadores se usan solo para conciliar fuentes.